

Gestion des AOD pour un acte invasif programmé

Méthodologie, gestes à risque faible/élevé, tableaux 1-2 & sources



Résumé : pour les actes programmés à risque hémorragique **faible**, il est proposé de ne pas prendre d'AOD la veille au soir ni le matin de l'intervention (quel que soit le schéma posologique), et de reprendre le traitement selon le schéma habituel au moins 6 heures après la fin du geste. Pour les actes à risque hémorragique **élevé**, dernière prise à J-3 pour rivaroxaban/apixaban/edoxaban ; dernière prise de dabigatran à J-4 (clairance de la créatinine [ClCr] ≥ 50 mL/min) ou J-5 (ClCr 30-49 mL/min). En neurochirurgie intracrânienne et anesthésie neuraxiale, délais plus longs. Plus de place pour les relais anticoagulants ni pour le dosage des concentrations d'AOD, sauf situations exceptionnelles.

Méthodologie et périmètre

Aucune grille de grade — ce document est un ensemble de **propositions** pragmatiques du Groupe d'Intérêt en Hémostase Périopératoire (GIHP), sans cotation formelle de la force des recommandations (ni GRADE, ni A/B/C, ni fort/faible Sfar). Aucun chip de grade n'est donc utilisé dans cette fiche.

■ **Doublon d'indexation** : ce document apparaît deux fois dans l'index bibliothèque du projet (« 2021 » et « 2015 », deux URL sfar.org différentes) mais il s'agit du **même document GIHP de septembre 2015** — page de titre et bibliographie de 18 références strictement identiques entre les deux PDF, seule la mise en page diffère (10 vs 14 pages). Le « 2021 » reflète la date de dernière modification de la page sfar.org, pas une nouvelle publication.

Distinct de la fiche « AOD : chirurgie et hémorragie en urgence » : ce document couvre la gestion **programmée** (acte électif, délai d'arrêt préétabli) ; l'autre fiche couvre la gestion en **urgence** (hémorragie, acte non programmé, thrombolyse). Deux documents complémentaires, non redondants.

1. Gestes à risque hémorragique faible

Thème	Proposition
Définition	Actes responsables de saignements peu fréquents, de faible intensité ou aisément contrôlés, réalisables chez un patient anticoagulé à taux thérapeutiques (critères HAS 2008 pour les AVK, étendus par extension aux AOD). Exemples non limitatifs : chirurgie cutanée, chirurgie de la cataracte, certains actes de rhumatologie, de chirurgie bucco-dentaire, d'endoscopie digestive.
Avant le geste	Pas de prise la veille au soir ni le matin de l'intervention, quel que soit le schéma posologique du patient (2 prises/j : saute les 2 prises précédant l'acte ; 1 prise le matin : saute 1 prise ; 1 prise le soir : saute 1 prise, dernière prise l'avant-veille au soir). Objectif : éviter une concentration plasmatique élevée pendant le geste, pas d'obtenir une concentration nulle.
Relai et dosage	Pas de relai par héparine (HNF/HBPM) en préopératoire. Pas d'indication à la mesure de la concentration de l'AOD avant l'intervention.
Après le geste	Reprise à l'heure habituelle du schéma du patient, au moins 6 heures après la fin de l'acte invasif (le soir de l'acte pour une prise unique le soir ou une prise biquotidienne ; le lendemain matin pour une prise unique le matin).
Accident hémorragique peropératoire	Le schéma postopératoire à appliquer devient celui du risque hémorragique élevé : reprise du traitement retardée, thromboprophylaxie veineuse (mécanique ou médicamenteuse) prescrite si risque thrombo-embolique.

2. Gestes à risque hémorragique élevé

Thème	Proposition
Définition	Geste ne pouvant raisonnablement être réalisé en présence d'anticoagulant (fenêtre sans anticoagulant nécessaire pour une hémostase optimale) — regroupe les catégories parfois distinguées ailleurs en « risque modéré » et « risque majeur ».

Gestion des AOD pour un acte invasif programmé

Méthodologie, gestes à risque faible/élevé, tableaux 1-2 & sources



Thème	Proposition
Avant le geste	Dernière prise à J-3 pour rivaroxaban, apixaban et edoxaban (ClCr > 30 mL/min, pharmacocinétiques similaires). Pour le dabigatran (élimination principalement rénale) : dernière prise à J-4 si ClCr ≥ 50 mL/min, à J-5 si ClCr entre 30 et 50 mL/min — nécessite une créatinémie récente (< 1 an en l'absence d'événement intercurrent). Ces délais supposent un schéma posologique adapté à la ClCr actuelle (formule de Cockcroft-Gault), à l'âge, et à l'absence d'interaction médicamenteuse susceptible d'augmenter les concentrations plasmatiques d'AOD (inhibiteurs de la P-glycoprotéine pour tous les AOD, inhibiteurs du CYP3A4 pour les -xabans).
Procédures à très haut risque hémorragique	Neurochirurgie intracrânienne, ponctions/anesthésies neuraxiales : schéma adapté par une équipe multidisciplinaire référente, délai d'arrêt plus long (dernière prise à J-5 pour les -xabans et le dabigatran en l'absence d'insuffisance rénale), sans relai héparinique. Techniques rachidiennes/blocs profonds déconseillés si une concentration détectable d'AOD reste possible — notamment dabigatran chez le patient > 80 ans ou insuffisant rénal.
Phase précoce d'un événement thromboembolique veineux	Sous rivaroxaban 15 mg x2/j (3 semaines) ou apixaban 10 mg x2/j (10 jours) en phase de traitement initial d'une TVP/EP, le schéma standard du Tableau 1 ne s'applique pas — programmer une chirurgie doit rester rare, stratégie personnalisée par une équipe multidisciplinaire référente.
Relai et dosage	Pas de relai héparinique en préopératoire avec les schémas proposés (sauf cas exceptionnel à très haut risque thrombotique, décision multidisciplinaire — AOD et héparine jamais administrés simultanément). Pas de dosage/test d'hémostase standard hors circonstance exceptionnelle ou recherche clinique, si les délais sont respectés et sans suspicion d'accumulation.
Après le geste — dose prophylactique	Si une thromboprophylaxie veineuse est indiquée : héparine (HNF/HBPM) ou fondaparinux au moins 6 heures après la fin de l'acte invasif ; l'AOD à dose adaptée à la prévention de la MTEV peut ensuite être prescrit, sans chevauchement lors du changement de molécule.
Après le geste — dose curative	Dès que l'hémostase chirurgicale le permet (à titre indicatif, entre 24 et 72 heures), l'AOD initial peut être repris à dose adaptée — sauf en présence d'un cathéter d'analgésie périmédullaire, où l'anticoagulation thérapeutique doit se faire par héparine jusqu'au retrait du cathéter. Première dose « curative » d'AOD administrée 12 heures après la dernière injection sous-cutanée d'HBPM à dose prophylactique.
Surveillance postopératoire	Créatinémie mesurée en postopératoire si l'acte et/ou l'état du patient font craindre une altération de la fonction rénale — une baisse de la ClCr impose d'adapter la dose d'AOD ou de changer de molécule anticoagulante.

Tableau 1 — Gestion périopératoire des AOD en fonction du risque hémorragique (transcrit fidèlement depuis un rendu visuel 220dpi, page 7 du PDF source)

	Risque hémorragique faible	Risque hémorragique élevé
Avant le geste	Pas de prise la veille au soir ni le matin de l'acte invasif	Rivaroxaban / apixaban / edoxaban, ClCr ≥ 30 mL/min → dernière prise à J-3 Dabigatran, ClCr ≥ 50 mL/min → dernière prise à J-4 Dabigatran, ClCr 30-49 mL/min → dernière prise à J-5
	Pas de relai — Pas de dosage	
Après le geste	Reprise à l'heure habituelle, au moins 6 h après la fin de l'acte invasif	Anticoagulant dose « prophylactique » au moins 6 h après l'acte si thromboprophylaxie indiquée ; dose « curative » dès que l'hémostase le permet (indicativement 24-72 h)

Tableau 2 — Indications et posologies usuelles des AOD (transcrit fidèlement depuis un rendu visuel 220dpi, page 8 du PDF source)

Indication	dabigatran Pradaxa®	rivaroxaban Xarelto®	apixaban Eliquis®	edoxaban Lixiana®
Prévention de la TVP après chirurgie orthopédique majeure	220 mg x1/j ou 150 mg x1/j si ClCr 30-50 mL/min, inhibiteurs P-gp, âge ≥ 75 ans — PTH : 28-35 j ; PTG : 10 j	10 mg x1/j — PTH : 5 sem. ; PTG : 2 sem.	2,5 mg x2/j — PTH : 32-38 j ; PTG : 10-14 j	NA

Gestion des AOD pour un acte invasif programmé

Méthodologie, gestes à risque faible/élevé, tableaux 1-2 & sources



Indication	dabigatran Pradaxa®	rivaroxaban Xarelto®	apixaban Eliquis®	edoxaban Lixiana®
Traitement de la TVP ou EP / prévention de la MTEV au long cours	150 mg x2/j ou 110 mg x2/j si âge ≥ 80 ans ou prise de vérapamil	15 mg x2/j (3 sem.), puis 20 mg x1/j	10 mg x2/j (7 j), puis 5 mg x2/j, puis 2,5 mg x2/j en prévention des récurrences après 6 mois de traitement d'une TVP/EP	60 mg x1/j ou 30 mg x1/j si ClCr 15-50 mL/min, poids ≤ 60 kg, inhibiteurs P-gp
Prévention des AVC et embolies dans la FA non valvulaire	150 mg x2/j ou 110 mg x2/j si âge ≥ 80 ans ou prise de vérapamil	20 mg x1/j ou 15 mg x1/j si ClCr 30-49 mL/min	5 mg x2/j ou 2,5 mg x2/j si 2 critères parmi : âge ≥ 80 ans, poids ≤ 60 kg, créatinine ≥ 133 µmol/L	60 mg x1/j ou 30 mg x1/j si ClCr 15-50 mL/min, poids ≤ 60 kg, inhibiteurs P-gp

TVP : thrombose veineuse profonde ; EP : embolie pulmonaire ; MTEV : maladie thromboembolique veineuse ; AVC : accident vasculaire cérébral ; FA : fibrillation atriale ; PTH/PTG : prothèse totale de hanche/genou ; ClCr : clairance de la créatinine (Cockcroft-Gault) ; P-gp : P-glycoprotéine ; NA : non applicable.

Sources et avertissement

GIHP, « Gestion des Anticoagulants Oraux Directs pour la chirurgie et les actes invasifs programmés : propositions réactualisées », septembre 2015 (réactualisation des propositions GIHP 2011). 18 références bibliographiques dans le texte intégral.

Avertissement — document de 2015 : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des propositions et des deux tableaux du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par le GIHP/SFAR. Les posologies, la disponibilité de nouveaux AOD/antidotes et les pratiques de gestion périopératoire ayant pu évoluer depuis 2015, se référer à un avis spécialisé et aux recommandations actualisées avant toute décision thérapeutique.